EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93803
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 30-09-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS ALBERTO VALLADARES LOPEZ			RUN	: 6.807.796-6
F.Nac	: 07-11-1950	Edad	: 73 AÑOS, 10 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: Brasil 1201			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-09-11	Fecha Egreso	: 30-09-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DG
ARTRITIS POR CRISTALES
NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA
¿ TROMBOEMBOLISMO PULMONAR ?
HIPERTENSION ARTERIAL
DIABETES MELLITUS
Hiperuricemia
Hipernatremie en vias de compensación
TU ENCEFALO OPERADO
HOSPITALIZACION PROLONGADA
DESNUTRICION CALORICO PROTEICA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. E79.0-HIPERURICEMIA SIN SIGNOS DE ARTRITIS Y ENFERMEDAD TOFACEA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

ANTEC DM-HTA-HIPOT, TU ENCEFALO OPERADO
HACE 2 AÑOS Y TRAS NEUROCX CON MULTIPLES CUADROS RESPIRATORIOS LO QUE A INTREPRETACION DE SU FAMILIA LO HA MERMADO FISICAMENTE, HASTA DEJARLO EN UNA SITUACION DE DEPENDENCIA MOD-SEVERA.
*
SE HOSPITALIZA POR MALESTAR GENERAL Y AUMENTO VOLUMEN RODILLA IZQ, SE REALIZÓ ESTUDIO LIQUIDO POR TRAUMATOLOGIA PLANTEANDOSE PROBABLE ARTRITIS POR CRISTALES SE MANEJA CON COLCHICINA CON FAVORABLE RESPUESTA CLINICA, AL INGRESO FALLA RENAL AG SOBRE CR, ORINA DE INGRESO INFLAMATORIA. RECIBE TERAPIA AB CEFTRIAXONA (UROCULTIVO NEGATIVO). CURSA CON HIPERCALCEMIA (CALCIURIA 24H BAJA, P ALTO, PTH 4)
DURANTE LA EVOLUCION POBRE ALIMENTACION POR BOCA, ESTADO DE CONCIENCIA FLUCTUANTE, SE INTENTÓ SNG SIN ÉXITO. DESARROLLA NEUMONIA NOSOCOMIAL (CSB 18.9.24 SAMR+PSEUDOMONAS) INICIA VANCO-CEFTAZIDIMA 21.9.24. CSB 23.9.24 SAMR. NUEVO QUIEBRE CLINICO EL 22.9.24 CON PROGRESIVA RESPUESTA CLINICA TRAS BIC HNF POR SOSPECHA TEP (POR PERSISTENCIA FALLA RENAL Y SITUACION GLOBAL SE ESTIMÓ NO REALIZAR ANGIOTAC)
SE LOGRA INSTALACION SNG EN LA ULTIMA SEMANA, SE MANTIENE AFEBRIL, HEMODINAMIA ESTABLE Y BAJO NUTRICION MIXTA SNG/ORAL, SIEMPRE FLUCTUANTE EN SU CONEXION CON EL MEDIO. TRAS COMPLIR TERAPIA AB SE DECIDE SU ALTA CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES
*
EXS 30.9.24 HB 11.3, GB 9300, PLT 350.000, VHS 100, CREA 2.3, NA 152, K 3.8, PCR 45, PROCALCITONINA 0.27

PLAN DE MANEJO:

SE DECIDE EN CONJUNTO CON SU FAMILIA (ESPOSA), MANEJO PROPORCIONAL EN MODELO HOSPIT DOMICILIARIA PARA FAVORECER KNT/FONO/REHABILITACION; CONTROL EXS 2.10.24
NUTRICION MIXTA, ORAL / SNG
P ELECTROFORESIS PROT SANGRE + INMUNOFIJACION
CONTROL EXS FXRENAL INR -> 2.10.24

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentado 30°
2. Regimen MIXTO -> SNG : GLUCERNA 40 CC /H + AGUA LIBRE 200 CC X 5 VECES AL DIA + PAPILLA ASISITIDO A TOLERANCIA
3. SF 0,45 % 1000 CC DIA
4. KNT motora / FONO / Cuidados de enfermeria prevencion UPP
5. MANEJO PROPORCIONAL
6. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. IPRATROPIO INHALADOR FRASCO UNIDAD 4 PUFF C/8 HR
8. SALBUTAMOL INHALADOR 100 MICROGRAMOS / DOSIS 2 PUFF C/8 HRS
9. COLCHICINA COMPRIMIDO 0,5 MILIGRAMOS 1 CP DIA SOLO LUNES Y VIERNES
10. METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
11. ACENOCUMAROL COMPRIMIDO 4 MILIGRAMOS 1/4 comprimido cada 24 hrs, (CONTROL CON INR 2.10.24)

CALDERON SOLIS CRISTIAN JOSE
MEDICO TRATANTE
15161784-0

JEFE SERVICIO